PEWNOŚĆ Z KAŻDYM PACJENTEM™

Sygnały Ostrzegawcze: Kiedy Skierować Pacjenta Dalej

Objawy, przy których praca z mapami nie powinna być pierwszym krokiem, oraz procedura skierowania krok po kroku.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny; nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Spis treści

1 · Podstawowa zasada

2 · Według obszarów

3 · Kroki skierowania

Kolejny krok

CZĘŚĆ 1

Podstawowa zasada

W razie wątpliwości nie podejmuj decyzji w pojedynkę.

Dlaczego to ważne

Dobry specjalista nie polega na rozwiązywaniu każdego problemu samodzielnie, lecz na wiedzy, kiedy sytuacja wymaga innego wsparcia. Skierowanie do odpowiedniego miejsca to wyraz troski, nie porażka.

CZĘŚĆ 2

Według obszarów

Sprawdź przy każdym nowym pacjencie.

Zawsze, w każdym obszarze

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Myśli, plany samobójcze lub wcześniejsze próby
- [ ] Samookaleczenia i autoagresja
- [ ] Stosowanie przemocy lub doświadczanie krzywdzenia (zwłaszcza z udziałem dzieci)
- [ ] Zaburzenia poczucia rzeczywistości (omamy, urojenia)
- [ ] Ciężkie zaburzenia snu, łaknienia lub funkcjonowania trwające od tygodni

Lęk i stres

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Objawy somatyczne niewyjaśnione dotąd medycznie (bóle w klatce piersiowej, omdlenia)
- [ ] Sięganie po substancje w celu stłumienia lęku
- [ ] Skrajne wycofanie: pacjent nie opuszcza mieszkania

Nastrój i emocje

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Utrzymujący się od tygodni spadek nastroju, anhedonia, bezradność
- [ ] Niezwykle podwyższony nastrój, brak potrzeby snu, zachowania ryzykowne
- [ ] Niepohamowane wybuchy złości niosące zagrożenie

Relacje i rodzina

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Sygnały przemocy w relacji intymnej
- [ ] Zachowania kontrolujące, groźby w otoczeniu pacjenta
- [ ] Zagrożenie dobra lub bezpieczeństwa dziecka

Trauma i bezpieczeństwo

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Ostre objawy bezpośrednio po świeżym zdarzeniu traumatycznym
- [ ] Częste stany dysocjacyjne
- [ ] Pacjent w dalszym ciągu żyje w warunkach bezpośredniego zagrożenia

Ciało i odżywianie

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Znaczny spadek masy ciała, odmawianie jedzenia, prowokowanie wymiotów
- [ ] Kompulsywny wysiłek fizyczny mimo kontuzji i wycieńczenia
- [ ] Dolegliwości somatyczne bez wcześniejszej diagnozy lekarskiej

Żałoba i strata

Jeśli to zauważysz: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej

- [ ] Osoba w żałobie deklaruje chęć śmierci, pragnie „dołączyć" do zmarłego
- [ ] Utrzymująca się miesiącami niezdolność do podstawowego funkcjonowania
- [ ] Używanie substancji psychoaktywnych w celu uśmierzenia bólu

CZĘŚĆ 3

Kroki skierowania

Spokojnie, bezpośrednio i przy aktywnym udziale pacjenta.

1. **Zapytaj wprost.** Pytanie o myśli samobójcze nie zwiększa ryzyka ich realizacji.
2. **Oceń aktualny poziom zagrożenia:** czy istnieje plan, dostęp do środków, określony czas, historia wcześniejszych prób?
3. **W sytuacji bezpośredniego zagrożenia** dzwoń pod 112 i nie pozostawiaj pacjenta bez opieki.
4. **Jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia:** ustal z pacjentem plan przekierowania (psychiatra, lekarz POZ, lokalne usługi zdrowia psychicznego).
5. **Zanotuj i udokumentuj** zaobserwowane objawy, przebieg rozmowy oraz ustalone kolejne kroki.
6. **Skonsultuj przypadek na superwizji** i zadbaj o własną przestrzeń emocjonalną.

Kolejny krok

Dzisiaj: wydrukuj wersję jednostronicową i umieść ją w widocznym miejscu w gabinecie lub miejscu pracy.